

中医药治疗慢性肾炎的研究进展*

孟凡东¹ 于秀梅²※

(1.山东中医药大学硕士研究生2020级,山东 济南 250014;2.聊城市中医医院肾内科,山东 聊城 252000)

摘要:慢性肾小球肾炎是常见的肾小球疾病,临床起病以蛋白尿、血尿、水肿和高血压为特点,伴或不伴有肾功能减退,发病机制尚未明确,现代研究认为其主要与免疫炎症损伤有关。慢性肾炎的中医病因病机复杂多变,不同医家有着不同见解,经近代医家研究证实,较单用西药治疗,加用中药治疗慢性肾炎,可以更明显地提高临床效果,改善症状,减轻肾组织损伤,保护肾功能。文章分别从基础实验研究和临床研究2个方面进行总结,并对其存在的问题进行探讨,提出不同的研究思路和研究方向,为中医药治疗慢性肾炎的研究提供新的参考依据。

关键词:尿血;慢性肾炎;中医药疗法;基础研究;临床研究;综述

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2023.11.069

文章编号:1672-2779(2023)-11-0202-04

Research Progress of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Chronic Nephritis

MENG Fandong¹, YU Xiumei²※

(1. Grade 2020 Graduate, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Shandong Province, Ji'nan 250014, China;

2. Department of Nephrology, Liaocheng Hospital of Traditional Chinese Medicine, Shandong Province, Liaocheng 252000, China)

Abstract: Chronic glomerulonephritis is a common glomerular disease. Its clinical onset is characterized by proteinuria, hematuria, edema and hypertension, with or without renal dysfunction. The pathogenesis is not clear yet, and modern studies believe that it is mainly related to immune inflammatory injury. The etiology and pathogenesis of chronic nephritis in traditional Chinese medicine are complex and changeable, and different doctors have different opinions. Through the research of modern doctors, compared with the treatment of Western medicine alone, adding traditional Chinese medicine to treat chronic glomerulonephritis can significantly improve the clinical effect, improve symptoms, reduce kidney tissue damage, protect renal function. The paper summarizes the basic experimental research and clinical research of traditional Chinese medicine in the treatment of chronic glomerulonephritis, discusses its existing problems, and puts forward different research ideas and research directions, so as to provide a new reference for the research of traditional Chinese medicine in the treatment of chronic glomerulonephritis.

Keywords: hematuria; chronic glomerulonephritis; therapy of traditional Chinese medicine; basic research; clinical research; review

慢性肾小球肾炎(Chronic glomerulonephritis, CGN),简称慢性肾炎,是以蛋白尿、血尿、水肿、

高血压伴缓慢进展的肾功能减退为临床特点的一组肾小球疾病,是我国常见的肾小球疾病,好发于中

tiology, different pathophysiologicals and treatment options[J]. Acta Derm Venereol, 2016, 96(5): 579-586.

[16] 王素环, 宋维芳, 林炳基, 等. 厦门市225例玫瑰痤疮患者临床特征及其危险因素分析[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2019, 33(1): 38-41.

[17] 丁惠玲, 韩娜娜, 仪晓芹, 等. 玫瑰痤疮生活质量调查分析[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2016, 30(12): 1271-1274.

[18] ALINIA H, CARDWELL L A, TUCHAYI S M, et al. Screening for depression in rosacea patients[J]. Cutis, 2018, 102(1): 36-38.

[19] 李爽, 张慧妍, 王立, 等. 多属性皮肤指标的中医体质模糊优化分类模型[J]. 计算机科学与探索, 2016, 10(7): 995-1002.

[20] 袁新, 汪霖, 邓智利, 等. 玫瑰痤疮发病机制研究进展[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2021, 35(8): 943-948.

[21] 徐爽. 坎离方治疗“火炎土焦证”玫瑰痤疮的临床疗效观察[D]. 南京: 南京中医药大学, 2020.

[22] 张瑞雪, 胡春福, 黄震, 等. 辨体质与解毒化浊通瘀相结合治疗玫瑰痤疮经验[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(4): 1546-1549.

[23] POTZ-BIEDERMANN C, MEHRA T, DEUTER C, et al. Ophthalmic rosacea: case report in a child and treatment recommendations[J]. Pediatr Dermatol, 2015, 32(4): 522-525.

[24] KELLEN R, SILVERBERG N B. Pediatric rosacea. Cutis, 2016, 98(1): 49-53.

[25] 王云, 宋琪, 龚娟, 等. 从肝郁探讨化肝煎治疗女性玫瑰痤疮[J]. 河南中医, 2020, 40(1): 78-81.

[26] 邹大涛. 基于“伏邪”理论自拟“青蒿透邪饮”治疗玫瑰痤疮(肺胃热盛证)的临床疗效观察[D]. 成都: 成都中医药大学, 2019.

[27] 黄柠, 颜仕立, 孙东杰. 凉血四物汤治疗玫瑰痤疮的Meta分析[J]. 皮肤病与性病, 2020, 42(5): 641-645.

[28] 时秀颖, 黄咏梅, 王萍. 针药结合从肝论治玫瑰痤疮的理论探析[J]. 云南中医中药杂志, 2019, 40(9): 91-93.

[29] 王云, 宋琪, 龚娟, 等. 从肝郁探讨化肝煎治疗女性玫瑰痤疮[J]. 河南中医, 2020, 40(1): 78-81.

[30] 李腾龙, 张红梅, 尹婧. 益气养阴散邪法治疗肺胃热盛证玫瑰痤疮的疗效及机制研究[J]. 中华中医药学刊, 2021, 39(10): 223-226.

[31] 王静. 基于朱丹溪滋阴思想的证治规律研究[D]. 济南: 山东中医药大学, 2012.

(本文责编: 王璞松皓 本文校对: 陈新 收稿日期: 2021-09-08)

* 基金项目: 山东省卫生健康委员会中医药高层次人才培养项目 [No. 505026]

※通信作者: mengfandong202203@163.com

青年,以男性多见^[1]。CGN为持续进展性疾病,最终可发展为终末期肾病。近年来,不同学者从中医角度对CGN进行探索和研究,并在基础研究和临床研究方面都取得了一定成果,为中医药治疗CGN的研究拓宽了思路。文章对近年来中医中药治疗CGN方面的研究进行综述。

1 中医学对慢性肾炎的认识

慢性肾炎在中医学中并无对应病名,但根据其血尿、蛋白尿、水肿和高血压等的临床表现可归属于“尿血”“尿浊”等范畴。现代中医医家根据自己的临床经验对慢性肾炎的病因病机及治疗有着不同的见解。

张大宁教授认为慢性肾炎的基本病机是脾肾气虚,治疗关键是健脾补肾、补气升提,主张用“补气升提法”治疗肾性蛋白尿、血尿,临床常用黄芪加少量升麻以补气升阳^[2]。李碧教授认为慢性肾炎病位在肾,病机上重视邪实,认为湿热、瘀血、风湿等实邪与正气相搏损伤肾脏,导致血尿、蛋白尿等,治疗上主张祛邪通络贯穿始终^[3]。周信有教授认为慢性肾炎的基本病机为虚实夹杂、正虚为本,责之肺、脾、肾,以肾虚为主、邪实为标,以湿、浊、瘀为主,治疗上强调扶正、利湿、祛瘀并重,气、血、水同治,基本治则为健脾益气、温肾利水、活血化瘀^[4]。李伟教授认为慢性肾炎的基本病机是肾虚湿热血瘀,肾虚是疾病发生的基础和关键,湿热和血瘀是疾病发展过程中的基本环节,主张根据不同时期和不同类型辨证施治^[5]。郭子光教授治疗慢性肾炎主张“从风论治”,认为风邪产生的原因有脾肾阳虚、肺脾气虚、肝肾阴虚,临床审因辨证,主张灵活应用风药,认为风药不仅有祛风的作用,还有活血、化瘀、消肿、化湿、促进生机等作用,故临床上即使没有明显风邪的症状,也常酌加风药^[6]。

2 慢性肾炎的中医药研究

2.1 基础研究 现代研究表明CGN发病机制与免疫炎症损伤有关,在此基础上,学者们分别从抑制炎症因子的产生和抑制炎症因子造成或加重肾组织损伤等方面,探讨中医药对CGN治疗作用的机制。

高家荣等^[7]研究探讨了芪藤消浊颗粒对CGN大鼠治疗作用的机制,结果表明其机制可能是通过抑制CGN大鼠中Syk/Ras/c-Fos信号通路来抑制白细胞介

素(IL)-6、IL-8、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)等炎症因子的产生,减轻肾小球组织的炎症反应,达到治疗的目的。付英杰等^[8]探讨爵床抑制肾炎细胞增殖的物质基础及作用机制,结果表明爵床可能是通过抑制TLR4/NF- κ B信号通路来抑制炎症蛋白的表达,减少炎症因子产生,从而达到抑制炎症细胞增殖的效果。李雯等^[9]研究雷公藤多苷对CGN大鼠肾组织炎症因子表达及p38MAPK信号通路的影响,结果表明雷公藤多苷可能通过抑制p38MAPK炎症信号通路来下调p-p38MAPK、p-CREB蛋白表达,从而抑制炎症因子对肾组织的损害。林劲等^[10]研究探讨了白芍总苷对CGN大鼠的肾脏保护作用及其作用机制,结果表明其机制可能是通过抑制p62、TRAF6、NF- κ B信号通路传导来抑制IL-1、TNF- α 等因子对肾脏造成损害。李红莲等^[11]观察丹酚酸B对CGN的作用、作用机制及对炎症、氧化和自噬的影响,结果表明其机制可能是通过降低肾脏炎症反应和氧化应激,促进肾脏自噬,以维持细胞内环境,从而减轻肾功能损伤。

2.2 临床研究

2.2.1 中药复方治疗 现代医家根据自己或者他人的临床经验,以及中医学的基础理论知识,选择治疗CGN效果明显的中药复方制剂来进行临床研究,以探讨中药复方治疗CGN的效果,指导临床用药,为新药研究提供方向。

黄东华等^[12]观察肾络通汤加减治疗65例CGN气虚血瘀证患者的临床效果,结果表明其可明显提高临床疗效,改善症状。其作用机制可能是通过抑制TNF- α 、IL-6和IL-1 β 等炎症因子的产生以减轻炎症反应,调节转化生长因子- β 1(TGF- β 1)、金属蛋白酶组织抑制剂-1(TIMP-1)和基质金属蛋白酶-9(MMP-9)等因子的水平以抑制肾纤维化。孔薇等^[13]探讨益肾清利方治疗30例CGN肾虚湿热证患者的临床效果,结果表明加用益肾清利方后,外周血清中TNF- α 、IL-6的水平均下降,IL-10水平较前升高,其作用机制可能是通过促进抗炎因子IL-10的增加,抑制促炎因子IL-6、TNF- α 的表达,从而达到促炎与抑炎的平衡,减少炎症因子对肾脏造成损伤。蒲春阳等^[14]观察运用补气通络、祛湿清热法治疗46例CGN肾虚热瘀型患者的临床效果,结果表明自拟汤剂肾炎康可提高临床疗效,推断其具有调

节免疫、改善微循环、修复肾小球内皮细胞、提高血浆白蛋白水平的作用。杨静等^[15]观察五苓散治疗52例CGN肺肾气虚证患者的临床效果,结果表明五苓散可以提高临床效果,改善浮肿、疲倦乏力、腰脊酸痛及少气懒言等症状,同时,炎症因子超敏C反应蛋白(hs-CRP)、IL-6及TNF- α 水平均较治疗前降低,表明五苓散具有抗炎活性、调节炎症因子水平、改善肾功能的作用。

2.2.2 中西医结合治疗 西药治疗CGN的作用有限,且有一定不良反应,因此临床上常用中药联合西药治疗,不仅可以提高临床效果,改善症状,还有较高的安全性,故现代医家常选择适合的中西医结合的治疗方案,进行研究、探讨。

陈翠强等^[16]观察脉络宁颗粒联合贝那普利治疗53例CGN患者的临床效果,结果表明联合用药可以提高临床疗效,其机制可能是通过抑制Th1型细胞免疫应答,促进Th2型细胞免疫应答,调节Th1/Th2细胞失衡,减轻炎症损伤,下调纤溶抑制物(TAFI),保护肾血管,从而改善患者的肾功能。陈晖等^[17]观察肾复康胶囊结合缬沙坦胶囊治疗52例CGN患者的临床效果,结果表明其可以提高临床疗效、改善肾功能指标、防止肾损伤、改善临床症状,作用机制可能是调节Th2型细胞的功能,抑制炎症反应,降低血管内皮生长因子(VEGF)、MMP-9、TIMP-1水平,保护肾脏,延缓肾小球的纤维化和硬化。胡韬韬等^[18]观察肾炎舒片联合来氟米特治疗49例老年CGN患者的临床效果,结果表明,联合用药可以提高临床疗效,其作用机制可能是通过降低TNF- α 、IL-6和IL-17水平,减轻炎症反应,延缓肾功能恶化。罗进辉等^[19]观察益肾化湿颗粒联合氯沙坦钾片治疗53例CGN患者的临床效果,结果表明二者联合可以提高临床疗效,可明显降低IL-13、CRP和TNF- α 水平,其作用机制可能是通过降低促炎因子水平,减轻肾实质炎症状态,保护肾功能。

2.2.3 辅助治疗 临床治疗中,除了药物的应用,辅助治疗也是不可或缺的手段。辅助治疗操作简单、费用较少,联合药物治疗可提高效果,无痛且安全性好,这就使得患者有较高的依从性,能够较好发挥治疗作用。

庞欣等^[20]观察隔姜灸联合补肾健脾方治疗49例CGN脾肾阳虚型患者的临床效果,结果表明联合隔姜灸可以提高疗效,明显改善水肿、腰膝酸软、畏寒肢冷、神疲乏力的症状,且不良反应少,安全性良好,值得在临床工作中推广应用。

3 慢性肾炎中医药治疗研究的思考

3.1 对基础研究的思考 CGN的发病机制尚不明确,现代研究^[21]证实,CGN的发生多与免疫炎症导致肾组织病理变化有关。多项研究^[7-11]表明,中医药在治疗CGN方面有着独特优势。近年来,中医药治疗CGN的研究已深入到分子生物学层面,为探索中医药的治疗作用并起效的本质提供线索,为临床研究和治疗CGN提供依据。在动物实验方面,近几年关于CGN与中医药的研究多与免疫炎症损伤有关,但除免疫因素外,非免疫因素如肾小球血流动力学改变等也会加剧肾小球损伤,近年来此类研究较少。目前,对中医药治疗影响CGN大鼠的细胞基因表达、信号转导的研究不全面。中药进入机体不单作用于肾脏,而是作用于整体,整体情况的改善或者机体某一情况的改善对CGN大鼠的影响的研究有限,中医药治疗CGN的多靶点研究、不同中药复方制剂对不同证型的CGN大鼠的治疗效果及作用机制的相关研究、不同证型的大鼠的内环境状态是否有差异、单味中药提取物的研究均进展缓慢,没能发现更行而有效的药物。因此,深入进行基础研究,揭示中医药、CGN与现代科学之间的内在关系和本质,为使用中医药治疗CGN的临床实践和研究提供指导。

3.2 对临床研究的思考 近年来,相关的临床研究^[12-19]表明,使用中药复方制剂或中药联合西药治疗,相比单纯使用西药治疗,可以提高临床效果,改善患者症状和体征,能有效降低尿蛋白和血肌酐水平,保护肾功能,减轻肾脏损伤,延缓肾功能不全的进展。目前,中医药治疗CGN的研究多为部分区域、小样本的临床研究,有待进行更具有说服力的、多中心、开放性、大样本的前瞻性研究,并为之后的临床研究提供理论依据和临床指导。同时,对一些疗效确切的中药复方制剂的作用机制尚不明确,缺乏对临床有效的中药复方治疗CGN多靶点的作用机制的研究;缺乏对不同体质的CGN患者的患

病情况和疾病演变情况的总结,以及中医药治疗效果和中医体质改变情况的研究;临床亦缺乏中医药治疗对非免疫因素的影响及其作用机制研究;在有效的复方中药中探寻单味中药、不同的药对、不同的药物剂量对CGN治疗作用的研究有限。近年来,除临床研究外,各中医大家治疗CGN的经验总结同样十分重要,不仅为临床实践做出指导,也为临床研究提供思路 and 方向。从各医家的临床经验中探索更有效的中药复方制剂、中药药对、单味中药等是临床工作者需要的工作。做好相关的临床研究,以期在中医药治疗CGN方面做出指导和贡献,丰富临床治疗内容,发展中医药学理论。

4 结语

CGN的中医病因病机纷繁复杂,且西医方面尚未明确其发病机制。中医学的整体观和辨证论治、中药材的数量庞大、中药组方的多样性以及中药的多靶点作用等都使得中医药在治疗CGN方面拥有独特优势。目前,在中医药治疗CGN的基础研究与临床研究2个方面已取得了阶段性的进展,但是亟待解决的问题仍有很多。这就需要中医学、临床医学、分子生物学等多个学科之间相互交叉融合,彼此渗透,只有这样才有望系统总结出更有效的临床经验,更加全面地探讨其作用机制。因此,在之前的研究基础上,加以整理和总结,并寻求突破和提高,为之后的基础研究、临床研究和治疗提供指导,为新药的研究与开发提供方向,为以后新理论的提出提供线索和依据。相信随着进一步的深入研究,在不久的将来,关于CGN的中医药治疗的研究必将达到更高的水平。

参考文献

- [1] 梅长林,余学清.内科学·肾脏内科分册[M].北京:人民卫生出版社,2015:58.
- [2] 樊威伟,徐英,周世芬,等.国医大师张大宁应用“补肾升提法”治疗肾性血尿理论探讨[J].中华中医药杂志,2018,33(2):561-563.
- [3] 刘星,吕允涛,李青.李碧教授“重邪实”辨治慢性肾小球肾炎经验[J].时珍国医国药,2018,29(5):1233-1234.
- [4] 杨佳楠,殷世鹏,陆航.国医大师周信有教授治疗慢性肾小球肾炎经验总结[J].中华中医药杂志,2018,33(11):4968-4971.
- [5] 刘瑶,李伟.慢性肾小球肾炎的中医病机与微观辨证研究探讨[J].世界科学技术-中医药现代化,2019,21(6):1062-1067.
- [6] 李凯,李秘,谢毅强,等.国医大师郭子光从风论治慢性肾炎经验摘英[J].中华中医药杂志,2020,35(10):4999-5002.
- [7] 高家荣,吴溪,宋俊梅,等.芪藤消浊颗粒对慢性肾小球肾炎大鼠Syk/Ras/c-Fos信号通路的调控作用[J].中药药理与临床,2017,33(5):143-149.
- [8] 付英杰,李悦,甘娇娥,等.爵床抑制肾炎细胞增殖的物质基础及作用机理[J].中成药,2018,40(4):783-787.
- [9] 李雯,陈春燕,罗宏丽.雷公藤多苷对慢性肾小球肾炎大鼠肾组织炎症因子表达的影响[J].中国临床药理学杂志,2020,36(19):3030-3032,3065.
- [10] 林劲,欧阳辉,梁春玲,等.白芍总苷对慢性肾小球肾炎模型大鼠的肾脏保护作用及机制研究[J].中药新药与临床药理,2021,32(10):1425-1430.
- [11] 李红莲,周桔,林华,等.丹酚酸B通过抗炎、抗氧化和促进自噬减轻慢性肾小球肾炎的肾功能损伤[J].中药药理与临床,2019,35(5):34-38.
- [12] 黄东华,何红涛,檀银川.肾络通汤对慢性肾小球肾炎患者TGF- β_1 , MMP-9和TIMP-1因子的影响[J].中国实验方剂学杂志,2017,23(15):196-201.
- [13] 孔薇,郑艳辉,张艳茹,等.益肾清利方对慢性肾炎肾虚湿证患者TNF- α 、IL-6、IL-10影响的研究[J].辽宁中医杂志,2017,44(5):999-1000.
- [14] 蒲春阳,栗睿.补气通络、祛湿清热法治疗肾虚热瘀型慢性肾小球肾炎临床疗效及作用机制的研究[J].中华中医药学刊,2017,35(6):1556-1559.
- [15] 杨静,申世华,刘静静.五苓散治疗肺肾气虚证慢性肾小球肾炎患者的临床疗效观察及对炎症因子的影响[J].中药新药与临床药理,2021,32(9):1386-1390.
- [16] 陈翠强,陈兴强,陈洁,等.脉络宁颗粒联合贝那普利治疗慢性肾小球肾炎的疗效及对外周血IL-4、IL-10、INF- γ 、TAFI的影响[J].中药材,2020,43(2):486-489.
- [17] 陈晖,曹昉,袁飞远.肾复康胶囊结合缬沙坦胶囊对慢性肾小球肾炎疗效、肾功能、血清炎症因子影响研究[J].中华中医药学刊,2021,39(9):177-180.
- [18] 胡韬韬,陈菁,李晶.肾炎舒片联合来氟米特对老年慢性肾小球肾炎疗效及对肾功能、血流动力学和炎症因子的影响[J].中国老年学杂志,2021,41(21):4734-4737.
- [19] 罗进辉,张慧.益肾化湿颗粒联合氯沙坦钾片治疗慢性肾小球肾炎的临床观察[J].中国药房,2017,28(29):4123-4126.
- [20] 庞欣,张建伟,王学敏.隔姜灸联合补肾健脾方治疗慢性肾小球肾炎的效果研究[J].中华中医药学刊,2020,38(8):254-258.
- [21] CARRARA C, EMILI S, LIN M, et al. Necrotizing and crescentic glomerulonephritis with membranous nephropathy in a patient exposed to levamisole-adulterated cocaine[J]. Clin Kidney J, 2016, 9(2): 234-238.

(本文责编:刘言言 本文校对:贾佑铎 收稿日期:2022-03-29)